Hjelp! Petter må bestå helsefag eksamen!!

Han trenger ekstra cash til en skikkelig klokke!!

HEA3103 Øvingscase: Bjørg (hoftebrudd og KOLS)

Øvingscase (én hovedoppgave, ca. oppgave 1-lengde)

Caset er et offentlig øvingseksempel beskrevet på fagarbeider.com (ikke et offisielt Udir-sett). Eksempelsvaret under er skrevet til denne samlingen.

Case / situasjon

Sted: Sykehjem / rehabilitering etter hoftebrudd

Pasient: Bjørg, 78 år.

Bakgrunn: Innlagt på sykehjem etter hoftebrudd. Har KOLS, er røyker og har nylig hatt infeksjon i nedre luftveier. Er i gang med rehabilitering, men blir fort andpusten ved mobilisering. Uttrykker bekymring for å falle igjen. Bodde tidligere hjemme med hjemmesykepleie to ganger daglig. Datteren er usikker på om moren kan flytte hjem igjen.

Diagnoser: Hoftebrudd; KOLS; nylig nedre luftveisinfeksjon.

Oppgaver og eksempelsvar

Oppgave 1

Oppgavetekst: Ta utgangspunkt i caset om Bjørg. Lag en tiltaksplan der du beskriver hva du vil gjøre, hvordan du vil gjøre det, og hvorfor. Vis at du ser hele pasienten, prioriterer tiltak og samarbeider med andre.

Eksempelsvar

Innledning

Bjørg er 78 år og er innlagt på sykehjem etter hoftebrudd. Hun har KOLS, røyker og har nylig hatt en infeksjon i nedre luftveier. Hun er i gang med rehabilitering, men blir fort andpusten når hun mobiliseres, og hun er redd for å falle igjen. Før bodde hun hjemme med hjemmesykepleie to ganger daglig, og datteren er usikker på om moren kan flytte hjem. Målet med tiltaksplanen er at Bjørg skal trene trygt, få pusten til å fungere best mulig, bli mindre redd for å falle og være med å planlegge veien videre.

Hoveddel

Det første jeg prioriterer, er å følge med på pusten. Hun har KOLS og har nylig hatt en luftveisinfeksjon, så det er fare for at pusten kan bli verre. Jeg observerer hvor fort og tungt hun puster, hudfarge, hoste og slim, og om hun virker mer sliten eller forvirret. Hvis det er rutine, kan jeg måle oksygenmetning og temperatur. Forverring

melder jeg til sykepleier med en gang. Jeg sørger for at hun sitter godt med hevet hodeende, fordi det gjør det lettere å puste.

Det andre er trening etter planen fra fysioterapeuten. Jeg passer på at hun har fått smertestillende i god tid før trening, slik sykepleier har planlagt, fordi smerter gjør at hun ikke tør eller orker å bevege seg. Vi trapper opp gradvis, fra sengekanten til stolen og korte turer med gåstol. Før vi går, minner jeg henne på leppepust, det vil si å puste ut gjennom sammenknepne lepper, som hun kan ha lært av fysioterapeuten. Det hjelper henne å få kontroll over pusten. Vi tar pauser når hun blir andpusten, og jeg går tett ved siden av henne. Når hun opplever at hun klarer mer enn hun trodde, blir hun tryggere.

Det tredje er å ta fallredselen på alvor. Jeg spør henne hva hun er redd for, og jeg lytter. Jeg forklarer at vi går trygt, at jeg er der, og at styrken hennes kommer tilbake med trening. Fallredsel kan føre til at hun beveger seg mindre, og da blir hun svakere og faller lettere. Derfor er det like viktig å støtte henne psykisk som fysisk. Jeg sørger også for at rommet er ryddig, at hun har gode sko og at ringesnoren er innen rekkevidde.

Jeg følger også med på andre ting som kan forsinke rehabiliteringen. Jeg oppfordrer henne til å drikke, fordi det gjør slimet lettere å hoste opp. Jeg legger til rette for næringsrik mat, fordi KOLS og infeksjon tærer på kreftene. Når hun ligger mye, sørger jeg for stillingsendring og ser etter trykksår. Røykingen er et tema som sykepleier og lege tar opp med henne. Jeg kan lytte hvis hun vil snakke om det, og jeg minner om at det er forbudt å røyke nær oksygen hvis hun får det.

Når det gjelder hjemreisen, spør jeg Bjørg hva hun selv ønsker, og om hun vil at datteren skal få informasjon og være med på møter. Pasient- og brukerrettighetsloven gir henne rett til å medvirke, og jeg har taushetsplikt etter helsepersonelloven. Med hennes samtykke kan datteren være med på et samarbeidsmøte med sykepleier, fysioterapeut og hjemmesykepleien. Da kan de sammen vurdere hva hun trenger for å klare seg hjemme.

Jeg dokumenterer pust, smerte, hvor langt hun gikk og hvordan hun hadde det, og gir rapport. Jeg evaluerer ved å se om hun går lenger med mindre tungpust, om smertene er under kontroll, om hun virker mindre redd og om planen for hjemreise blir tydeligere.

Avslutning

Tiltaksplanen ser hele Bjørg: hoftebruddet, KOLS, fallredselen og spørsmålet om hjemreise. Jeg prioriterer pusten og trygg trening, støtter henne psykisk og samarbeider med sykepleier, fysioterapeut og datteren når Bjørg samtykker. Slik får hun best mulig grunnlag for å bli sterkere og ta et valg om veien videre.

Eksempelsvar til øving, skrevet med sikte på et nivå mellom karakter 4 og 5. Uoffisielt – ikke en karaktergaranti eller offisielt fasitsvar.